



Curso

**ATENÇÃO À SAÚDE DA
CAMINHONEIRA E
CAMINHONEIRO NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA**

Módulo IV

**Cuidado Integral à Caminhoneira e
ao Caminhoneiro com Doenças
Crônicas e Outras Afecções**

Fiocruz Mato Grosso do Sul

AUTORES

Dijon Hosana Souza Silva – <http://lattes.cnpq.br/8533706863923000>

Alessandra Aparecida Vieira Machado – <http://lattes.cnpq.br/0671841036495321>

SUMÁRIO

4.1 Perfil epidemiológico e Doenças Crônicas Não Transmissíveis no contexto das estradas

4.1.1 Características sociodemográficas de caminhoneiras e caminhoneiros

4.1.2 Condições de trabalho e determinantes sociais de saúde

4.1.3 Principais fatores de risco (comportamentais, ambientais e ocupacionais)

4.1.4 Conceito e classificação das Doenças Crônicas Não Transmissíveis

4.1.5 Doenças Crônicas Não Transmissíveis prevalentes na população caminhoneira

4.1.6 Impacto das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na qualidade de vida e na capacidade laboral

4.2 Detecção precoce, manejo e acompanhamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde para caminhoneiras e caminhoneiros

4.2.1 Hipertensão arterial sistêmica

4.2.2 Diabetes mellitus

4.2.3 Obesidade

4.2.4 Estratégias de cuidado centradas na caminhoneira e no caminhoneiro na Atenção Primária à Saúde

4.3 Promoção da saúde, prevenção de agravos e estratégias de cuidado

4.3.1 Redução de comportamentos de risco

4.3.2 Desafios da vinculação territorial

4.3.3 Integração com a Rede de Atenção à Saúde

APRESENTAÇÃO DO MÓDULO

Seja bem-vindo ao Módulo IV! Considerando todo o contexto e as especificidades já estudadas até aqui, daremos continuidade às reflexões e adicionaremos uma nova camada.

Neste módulo, vamos compreender as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no contexto de trabalho das caminhoneiras e dos caminhoneiros, e discutir estratégias práticas de cuidado na Atenção Primária à Saúde (APS).

Você sabia que o Brasil apresenta uma extensa malha rodoviária que ultrapassa 1,72 milhão de km? Nesse cenário, mais de 1,23 milhão de pessoas caminhoneiras sustentam a logística nacional, transportando nossos alimentos, roupas, combustíveis etc.

Entretanto, esses trabalhadores enfrentam barreiras importantes: longas jornadas, distância da família, perdas salariais, alimentação inadequada, pouco acesso à saúde e exposição a fatores de risco, incluindo acidentes e violência nas estradas. Por isso, convidamos você a se perguntar: como podemos ser mais resolutivos no atendimento das caminhoneiras e dos caminhoneiros e ajudá-los a cuidar da própria saúde?

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Reconhecer o perfil epidemiológico das DCNT nas caminhoneiras e nos caminhoneiros, identificando fatores de risco associados ao contexto laboral nas estradas.
2. Identificar critérios clínicos e estratégias de rastreamento que orientam a detecção precoce de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus no âmbito da APS.
3. Analisar estratégias de manejo e acompanhamento das DCNT na APS, considerando acolhimento, vínculo, escuta qualificada e cuidado longitudinal.
4. Reconhecer sinais de alerta e situações clínicas relacionadas às DNCT que demandam encaminhamento oportuno ou acionamento da rede de urgência e emergência.
5. Identificar ações de promoção da saúde e prevenção voltadas a outras afecções frequentes nas caminhoneiras e nos caminhoneiros, como doenças osteomusculares, câncer de pele e condições geniturinárias.
6. Analisar estratégias que ampliem a resolutividade e a continuidade do cuidado das DCNT nas caminhoneiras e nos caminhoneiros, considerando a mobilidade e os desafios de vinculação territorial.

CARGA HORÁRIA DE ESTUDO

07 horas.

4.1 Perfil epidemiológico e Doenças Crônicas Não Transmissíveis no contexto das estradas

Ao pensar na saúde das caminhoneiras e dos caminhoneiros, é importante irmos além das doenças em si e compreendermos o contexto em que essas pessoas vivem e trabalham.

Quem são esses trabalhadores? Como vivem? Quais desafios enfrentam no cotidiano? E, principalmente, como essas condições influenciam o desenvolvimento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis? É a partir dessas perguntas que começamos este percurso.

4.1.1 Características sociodemográficas de caminhoneiras e caminhoneiros

Conforme relatório da Childhood Brasil (2025), a população de caminhoneiros é composta majoritariamente por homens, com idade média em torno de 30 a 50 anos e longa permanência na profissão. Muitos iniciam a atividade ainda jovens e continuam nela por décadas.

Nos últimos anos, observa-se um aumento gradual da participação feminina, embora ainda seja minoritária. As mulheres caminhoneiras frequentemente enfrentam desafios adicionais, como questões relacionadas à segurança, infraestrutura inadequada e sobrecarga de responsabilidades familiares.

Em relação à escolaridade, há predominância de ensino fundamental e médio, o que

Reflexão

Ao atender uma caminhoneira ou um caminhoneiro, você costuma adaptar sua comunicação considerando o nível de escolaridade e o contexto de vida dessa pessoa?

pode influenciar tanto o acesso à informação quanto a compreensão de orientações em saúde.

4.1.2 Condições de trabalho e determinantes sociais de saúde

A rotina nas estradas impõe uma série de condições que impactam diretamente a saúde. Entre os principais aspectos, destacam-se:

- longas jornadas de trabalho, frequentemente superiores a 10-12 horas diárias;
- distância da família;

- permanência prolongada em posição sentada;
- irregularidade nos horários de sono;
- alimentação baseada em opções disponíveis nas estradas;
- dificuldade em acessar serviços de saúde.

Além disso, os locais de parada, como postos de combustível e pátios, nem sempre oferecem condições adequadas de higiene, descanso e cuidado.

Esses fatores configuram importantes **determinantes sociais de saúde**, influenciando diretamente o risco de adoecimento. Por isso, é muito importante compreender o contexto de vida da caminhoneira e do caminhoneiro para propor orientações e ações viáveis para esse estilo de vida.

4.1.3 Principais fatores de risco (comportamentais, ambientais e ocupacionais)

As condições descritas anteriormente favorecem a exposição a diversos fatores de risco para DCNT.

Ao observar o Quadro 1, pense: quais desses fatores são mais frequentes na realidade das pessoas que você atende? E quais deles são, de fato, possíveis de serem modificados no contexto das estradas?

Quadro 1. Fatores de risco à saúde no contexto do trabalho das caminhoneiras e dos caminhoneiros

Categoria	Fatores de risco	Como se manifestam no contexto das estradas	Implicações para a saúde
Comportamentais	-Alimentação inadequada -Sedentarismo -Tabagismo -Consumo de álcool	-Refeições com baixa qualidade nutricional -Longos períodos sem atividade física -Uso de cigarro para lidar com o estresse -Consumo de álcool em momentos de descanso	-Aumento do risco de obesidade -Hipertensão arterial -Diabetes mellitus -Doenças cardiovasculares
Ambientais	-Poluição atmosférica -Exposição solar prolongada -Ruído constante	-Permanência em rodovias com alta emissão de poluentes -Exposição ao sol enquanto dirigem e também durante carga/descarga	-Doenças respiratórias -Câncer de pele -Estresse crônico -Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR)

Categoria	Fatores de risco	Como se manifestam no contexto das estradas	Implicações para a saúde
		-Ambientes ruidosos e estressantes	
Ocupacionais	-Jornadas prolongadas -Privação de sono -Estresse	-Turnos extensos e irregulares -Dormir em condições inadequadas -Pressão por prazos -Uso de substâncias para manter-se acordado	-Permanência por longos períodos na posição sentada -Dores crônicas de coluna -Problemas circulatórios -Fadiga -Alterações metabólicas -Maior risco de acidentes -Agravamento de DCNT

Fonte: elaboração dos autores, 2025.

Dica

Possibilidades de abordagem na prática:
O primeiro passo é reconhecer que, para a caminhoneira e o caminhoneiro, muitas recomendações tradicionais de saúde não são facilmente aplicáveis. Por isso, o cuidado precisa ser realista, negociado e adaptado à rotina da estrada.

Veja algumas estratégias possíveis:

✓ 1. Negociar, em vez de prescrever.
Em vez de orientar mudanças rígidas, busque construir acordos possíveis:

- “Dentro da sua rotina, o que você acha que conseguiria mudar primeiro?”
- “Entre essas opções, qual seria mais viável para você na estrada?”

Isso aumenta a adesão e respeita a autonomia do paciente.

✓ 2. Adaptar a alimentação à realidade da estrada.
Em vez de recomendar “alimentação ideal”, oriente escolhas possíveis, como:

- priorizar refeições como arroz, feijão e proteína, quando disponíveis;
- evitar excesso de frituras sempre que possível;
- incentivar o consumo de água ao longo do dia;
- sugerir a redução progressiva do número de cigarros e, também, sugerir fortemente o uso do álcool apenas nos momentos de descanso prolongados ou em casa.

4.1.4 Conceito e classificação das Doenças Crônicas Não Transmissíveis

As DCNT são doenças de longa duração, geralmente de progressão lenta, e resultam da interação de múltiplos fatores genéticos, comportamentais, ambientais e sociais.

Entre as principais características, destacam-se: curso prolongado; necessidade de acompanhamento contínuo; impacto significativo na qualidade de vida; potencial de gerar incapacidades.

As DCNT mais relevantes no contexto da saúde pública incluem:

- doenças cardiovasculares (pressão alta, doenças do colesterol, infartos, derrames, trombose etc.);
- diabetes mellitus;
- doenças respiratórias crônicas (asma, bronquite e outras doenças do pulmão e das vias respiratórias);
- neoplasias.

No contexto da população caminhoneira, essas condições assumem particular relevância devido à elevada exposição a fatores de risco.

Lembre-se de que a maioria das DCNT está relacionada a fatores modificáveis, como perda de peso, atividade física regular e alimentação adequada, que podem prevenir ou retardar sua evolução.

Saiba mais

Aprofunde seus conhecimentos lendo o *Plano De Ações Estratégicas Para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030*. Um excelente material elaborado pelo Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis.

Disponível em: [09-plano-de-dant-2022_2030.pdf](#).

4.1.5 Doenças Crônicas Não Transmissíveis prevalentes na população caminhoneira

Quando analisamos a saúde das caminhoneiras e dos caminhoneiros, um aspecto chama atenção: a elevada carga de DCNT, muitas vezes associadas entre si e, frequentemente, subdiagnosticadas.

Mas, afinal, o que os estudos mostram sobre isso?

Hipertensão arterial: A hipertensão arterial é uma das condições mais prevalentes nessa população. Um estudo com caminhoneiros brasileiros e latino-americanos aponta prevalências que variam entre 31% e 33%, valores semelhantes ou até superiores à média da população geral (Krishnamoorthy; Sarveswaran; Sakthivel, 2020). Esse dado é especialmente preocupante porque: a) muitas pessoas não sabem que são hipertensas; b) a condição pode permanecer assintomática por anos; c) está diretamente associada ao risco de infarto e AVC. Na prática, isso reforça a importância do incentivo ao cuidado integral assim que ocorrer o primeiro contato com o serviço de saúde.

Diabetes mellitus: O diabetes também está presente de forma significativa, embora com menor prevalência em comparação à hipertensão. Estudos indicam predomínio em torno de 9% entre caminhoneiros, podendo ser maior quando considerados casos não diagnosticados

(Zamparoni Victorino, 2023). Além disso, há um número expressivo de caminhoneiras e caminhoneiros com alterações do metabolismo glicídico (glicemia de jejum alterada, tolerância diminuída à glicose), que não são identificados adequadamente e, com frequência, coexistem com obesidade. Ou seja, existe uma janela importante para intervenção precoce.

Obesidade e excesso de peso: Este é um dos achados mais consistentes na literatura. Cerca de 56% dos caminhoneiros apresentam sobrepeso ou obesidade — sendo que, em alguns estudos brasileiros, esse número pode chegar a 70% ou mais. Há, ainda, pesquisas que mostram uma taxa de 20% com obesidade estabelecida e presença de obesidade grave em uma parcela relevante de pessoas (Reis *et al.*, 2017; Zamparoni Victorino, 2023). Entre pessoas camonhoneiras, a irregularidade dos horários de trabalho e a imprevisibilidade das rotas dificultam a manutenção de hábitos saudáveis. Esse cenário está associado à alimentação inadequada nas estradas, ao sedentarismo, ao descanso insuficiente e à baixa regularidade na prática de exercícios físicos. Nesse contexto, a obesidade atua como um elo central entre diferentes Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), especialmente por contribuir para maior risco cardiometabólico.

Doenças cardiovasculares e síndrome metabólica: A combinação de fatores de risco, hipertensão, obesidade, doenças do colesterol e aumento do açúcar no sangue favorece o desenvolvimento da chamada síndrome metabólica, altamente prevalente entre motoristas profissionais. Essa condição aumenta significativamente o risco cardiovascular e, estando associada ao estilo de vida sedentário, tende a se agravar com o tempo de profissão: quanto maior o tempo na estrada, maior tende a ser o risco acumulado.

Doenças osteomusculares: Embora, muitas vezes, não classificadas diretamente como DCNT clássicas, essas condições são extremamente frequentes. Lombalgia e dores crônicas são altamente prevalentes e estão associadas à postura prolongada e ao esforço físico. Essas

Saiba Mais

Assista ao vídeo sobre ginástica laboral de autoria do Programa Brasil Caminhoneiro. Trata-se de orientações simples e fáceis para que você, estudante profissional da saúde, oriente a pessoa caminhoneira para prevenção de problemas osteoarticulares. Duração de 1:50 min.

Disponível em: [Ginástica Laboral para a turma estradeira](#).

condições impactam diretamente a capacidade de trabalho e a qualidade de vida, além de aumentar o risco de afastamento laboral.

Doenças de pele: A exposição solar contínua durante atividades como carga e descarga aumenta o risco de lesões cutâneas, envelhecimento precoce da pele e câncer de pele. Esse é um agravo frequentemente negligenciado, mas altamente relevante em profissionais expostos ao sol (Brasil, 2025).

4.1.6 Impacto das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na qualidade de vida e na capacidade laboral

As DCNT não afetam apenas a saúde, elas também impactam diretamente o cotidiano e o trabalho. Entre os principais efeitos, destacam-se: a) redução da capacidade funcional; b) dor crônica (especialmente musculoesquelética); c) fadiga e queda de desempenho; d) maior risco de acidentes; e e) afastamento do trabalho.

Além disso, o diagnóstico tardio e o acompanhamento irregular podem agravar o quadro clínico, levando a complicações evitáveis. Dessa forma, quando observamos esses números em conjunto, fica claro que: as DCNT não ocorrem isoladamente, havendo uma forte sobreposição de fatores de risco e existindo um padrão de adoecimento crônico progressivo.

Em outras palavras: estamos diante de uma população com alto risco cardiovascular e metabólico acumulado. Diante desses dados, vale perguntar:

- “Quantas dessas condições poderiam ser identificadas mais precocemente na APS?”
- “Quantas dessas condições poderiam ser evitadas com intervenções simples, porém oportunas?”

4.2 Detecção precoce, manejo e acompanhamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde para caminhoneiras e caminhoneiros

Na APS, o cuidado das DCNT deve ser contínuo, resolutivo e adaptado à realidade da população caminhoneira, as quais, muitas vezes, não conseguem manter acompanhamento regular.

Quando se fala em cuidar de uma população itinerante e móvel, este cuidado exige ser resolutivo e adaptado à realidade delas, pois não conseguem manter acompanhamento regular. Por isso, mais do que seguir protocolos, é fundamental identificar oportunidades de cuidado e adaptar estratégias à mobilidade dessa população.

4.2.1 Hipertensão arterial sistêmica

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é frequentemente assintomática e, por isso, depende de rastreamento ativo. Nesse sentido, a detecção precoce é primordial! Considerando toda a singularidade do estilo de vida e de trabalho dessa população, devemos aproveitar todas as oportunidades para detecção precoce ao: a) aferir pressão arterial sempre que possível; b) confirmar diagnóstico com medidas repetidas ($\geq 140/90$ mmHg); e c) identificar fatores de risco associados.

Saiba mais

Aprofunde seus conhecimentos sobre o diagnóstico de HAS, dislipidemias e diabetes mellitus, acessando os conteúdos da Associação Brasileira de Cardiologia atualizado em 2020. Lá, estão detalhados os protocolos e guias para diagnóstico, manejo e tratamento. Disponível em:

- [Página Inicial - ABC Cardiol](#);
- [Diretriz-HAS-2020.pdf](#);
- [protocolo-clinico-de-diretrizes-terapeuticas-pcdt-para-diabetes-mellitus-tipo-ii](#)

- **Manejo na APS:** orientar mudanças no estilo de vida (adaptadas à rotina da estrada); recomendar terapia medicamentosa conforme diretrizes; promover educação em saúde com foco em adesão às linhas de cuidado.
- **Acompanhamento:** realizar monitoramento periódico (mesmo que irregular); efetuar registro clínico para continuidade do cuidado; orientar sobre sinais de alerta.

Atenção! Mesmo uma única aferição pode ser decisiva para iniciar o cuidado em pessoas com baixo acesso ao serviço. Uma medida isolada da pressão arterial $\geq 180/110$ mmHg define o diagnóstico de HA Estágio 3 e indica a necessidade de tratamento de início imediato.

4.2.2 Diabetes mellitus

O diabetes frequentemente apresenta diagnóstico tardio, especialmente em populações com baixa vinculação. A indicação de rastreamento está resumida na Figura 1.

Figura 1. Indicações para rastreamento de Diabetes Mellitus tipo 2 em adultos assintomáticos



Acantose nigricans: alteração cutânea caracterizada por áreas hiperpigmentadas e espessadas, frequentemente associada à resistência à insulina e ao risco cardiometabólico. **FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score):** instrumento de rastreamento utilizado para estimar o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 nos próximos 10 anos, com base em fatores clínicos e comportamentais.

Fonte: imagem gerada por meio de IA, com base em SBD, 2025.

- **Manejo na APS:** orientar sobre a alimentação viável na estrada e o uso de medicações para o diabetes e de aparelhos portáteis para medir o açúcar no sangue (glicosímetro).

Na tabela a seguir, estão resumidos os valores de referência atualizados.

Tabela 1. Critérios laboratoriais para diagnóstico de diabetes mellitus e pré-diabetes

Critérios	Normal	Pré-Diabetes	Diabetes mellitus
Glicemia de jejum* (mg/dl)	< 100	100–125	≥ 126
Glicemia ao acaso (mg/dl) + sintomas	-	-	≥ 200

Glicemia de 1h no TTGO** (mg/dl)	< 155	155–208	≥ 209
Glicemia de 2h no TTGO (mg/dl)	< 140	140–199	≥ 200
HbA1c (%)	< 5,7	5,7–6,4	≥ 6,5

TTGO: teste de tolerância à glicose-oral; **HbA1c:** hemoglobina glicada; *Considera-se jejum a cessão de ingesta calórica de 8–12 horas. **Carga oral equivalente a 75 g de glicose anidra diluída em água.

Fonte: SBD, 2025.

- **Acompanhamento:** avaliar complicações (pé diabético, visão, função renal); reforçar continuamente a adesão ao tratamento.

4.2.3 Obesidade

A obesidade é altamente prevalente e atua como fator central para outras DCNT.

- **Avaliação:** Índice de Massa Corporal (IMC); circunferência abdominal.
- **Manejo na APS:** recomendar mudanças graduais no padrão alimentar; incentivar a atividade física adaptada; fazer uma abordagem não estigmatizante (por exemplo, evitar comentários estéticos sobre o peso).
- **Acompanhamento:** monitorar peso e comorbidades; reforçar de metas realistas.

Lembre-se: Pequenas mudanças sustentáveis são mais eficazes do que recomendações rígidas!

4.2.4 Estratégias de cuidado centradas na caminhoneira e no caminhoneiro na Atenção Primária à Saúde

O cuidado na APS deve considerar a mobilidade, a irregularidade de acesso e o contexto de vida dessas pessoas. Então, é preciso que você esteja atento a essas condições e, na sua prática profissional, leve em consideração os pontos expostos a seguir.

Acolhimento e escuta qualificada: O acolhimento qualificado é o primeiro passo para adesão. Para praticá-lo, você pode:

- escutar sem julgamento;
- reconhecer limites reais da rotina;
- adaptar orientações ao contexto.

Construção de vínculo em contextos de baixa territorialização: O vínculo não depende apenas da frequência, mas também da qualidade da interação. Então, é preciso:

- valorizar cada contato como oportunidade;
- garantir continuidade do cuidado por meio de registro adequado;
- fortalecer a relação de confiança.

Cuidado longitudinal em populações itinerantes: O cuidado precisa “acompanhar” o usuário, mesmo fora do seu território de referência. Garanta que isso aconteça ao:

- planejar o cuidado considerando deslocamentos;
- articular com diferentes serviços da rede;
- incentivar o autocuidado orientado.

Abordagem oportunística (consultas, ações em rodovias e Pontos de Parada e Descanso – PPD): Cada encontro é uma janela de oportunidade para a promoção do cuidado em saúde. Para isso,

- Aproveitar qualquer contato para promover o cuidado integral.
- Realizar ações educativas em PPD e nas estradas e/ou rodovias.
- Integrar ações de promoção, prevenção e diagnóstico precoce.

Uso de tecnologias (telemonitoramento e prontuário eletrônico): O uso de tecnologias digitais tem se consolidado como estratégia central para qualificar o cuidado na Atenção Primária à Saúde, especialmente para populações com alta mobilidade, como as caminhoneiras e os caminhoneiros. No Brasil, esse movimento foi fortalecido com a implementação do Programa SUS Digital (2023), que tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde por meio da transformação digital, promovendo integração, continuidade do cuidado e redução de desigualdades. Nesse sentido, a tecnologia pode reduzir barreiras de acesso e melhorar a longitudinalidade do cuidado. Algumas ações são possíveis por meio dessas tecnologias, tais como:

- registro em prontuário eletrônico para continuidade do cuidado;
- acesso ao histórico do paciente em diferentes serviços da APS;
- acompanhamento remoto de condições como HAS e DM;
- reforço de orientações e adesão ao tratamento.

4.3 Promoção da saúde, prevenção de agravos e estratégias de cuidado

A promoção da saúde no contexto das estradas exige uma abordagem realista, acessível e centrada na população caminhoneira. Mais do que orientar mudanças ideais, é necessário construir estratégias possíveis, considerando as limitações da rotina, da mobilidade e do acesso aos serviços.

No contexto das estradas, a educação em saúde deve ser:

- clara, objetiva e adaptada à realidade;
- baseada em situações concretas do cotidiano;
- realizada de forma oportunística (consultas e ações em rodovias e PPD).

É importante priorizar: linguagem acessível, orientações práticas e aplicáveis e estímulo à autonomia e ao autocuidado. Educar, nesse contexto, é traduzir conhecimento em ações possíveis na estrada.

Alimentação saudável possível: deve ser orientada considerando as limitações de oferta alimentar nas rodovias. Algumas estratégias viáveis são: priorizar refeições com alimentos *in natura* ou minimamente processados, quando disponíveis; reduzir consumo de frituras, ultraprocessados e bebidas açucaradas; incentivar hidratação regular; orientar planejamento alimentar, quando possível. O foco deve ser na melhoria progressiva, e não na perfeição alimentar.

Atividade física adaptada: deve ser integrada à rotina da estrada. Algumas recomendações práticas são: alongamentos durante pausas; caminhadas curtas em paradas; movimentos simples fora do veículo. Mesmo as pequenas atividades contribuem para redução do risco cardiovascular, controle do peso e melhora do bem-estar. Para isso, a atividade física deve ser **possível, breve e incorporada ao cotidiano**.

Há vários vídeos de caminhoneiras e caminhoneiros nas redes sociais, incentivando outros colegas de profissão a deixarem o sedentarismo e mostrando que, mesmo com uma jornada puxada, é possível implementar exercícios físicos na rotina diária. Inspire-se nas experiências compartilhadas por esses profissionais assistindo aos vídeos:

- 1- Caminhoneiro QRA Sobrinho, duração 4:26 min. Disponível em: [Caminhoneiro resolve fazer atividades físicas](#) 
- 2- Caminhoneiro Vinicius Amorim, duração 12:30 min. Disponível em: [TREINANDO NO CAMINHÃO - CAMINHONEIRO NA EUROPA](#)
- 3- Caminhoneiro Professor Truckado, duração 5:56 min. Disponível em: [EXERCICIOS FISICOS DE UM CAMINHONEIRO](#)

4.3.1 Redução de comportamentos de risco

A abordagem deve priorizar redução de danos, especialmente em relação a tabagismo, consumo de álcool, uso de substâncias estimulantes e privação de sono. Tenha em mente que pequenas reduções já produzem impacto significativo na saúde.

A seguir, veja algumas estratégias:

- orientação sem julgamento;
- estabelecimento de metas graduais;
- identificação de situações de risco.

4.3.2 Desafios da vinculação territorial

Na população caminhoneira, a construção do vínculo na Atenção Primária à Saúde exige adaptação às limitações impostas pela mobilidade e pela baixa frequência de retorno. Nesse contexto, o profissional deve valorizar cada contato como uma oportunidade única de cuidado, buscando realizar uma abordagem resolutiva que integre avaliação, orientação e conduta no mesmo atendimento.

O registro qualificado em prontuário eletrônico torna-se essencial para garantir a continuidade do cuidado por outros serviços, devendo conter informações claras e completas. Além disso, é fundamental oferecer orientações práticas, acessíveis e portáteis, que permitam ao paciente dar seguimento ao cuidado de forma autônoma. O estímulo ao autocuidado orientado, com metas realistas e reconhecimento de sinais de alerta, contribui para maior segurança e adesão.

A abordagem oportunística deve ser incorporada à rotina, aproveitando qualquer contato com o serviço para rastreamento e intervenção. Também é importante orientar o usuário sobre a possibilidade de acessar diferentes unidades de saúde ao longo do território, reforçando o SUS como uma rede integrada.

Por fim, o uso de tecnologias, como prontuário eletrônico e telemonitoramento, e a adoção de uma comunicação acolhedora e sem julgamento fortalecem o vínculo, tornando o cuidado mais acessível, contínuo e centrado na realidade da população caminhoneira — vide esquematização na Figura 2. Lembre-se de que o vínculo precisa ser construído, mesmo sem presença contínua do paciente no território.

A continuidade do cuidado é um dos maiores desafios nessa população. Para garanti-la, é necessário registro em prontuário eletrônico, orientação clara para seguimento, estímulo ao autocuidado e articulação com diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde local. O cuidado não pode depender apenas da presença física: ele precisa ser transferível e acessível.

4.3.3 Integração com a Rede de Atenção à Saúde

A integralidade do cuidado depende da articulação entre os diferentes níveis da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Os elementos-chave para que isso aconteça são: comunicação entre serviços; referência e contrarreferência; uso de sistemas de informação (RNDS e prontuário eletrônico) e apoio da telessaúde.

Essa integração permitirá melhor acompanhamento das DCNT, redução das perdas no seguimento e aumento da resolutividade da APS. Para a caminhoneira e o caminhoneiro, a rede precisa funcionar como um sistema interligado e contínuo, independentemente do território.

Figura 2. Estratégias para construir vínculo com a pessoa caminhoneira



ENCERRAMENTO DO MÓDULO

Neste módulo, você refletiu sobre os principais desafios no cuidado às caminhoneiras e aos caminhoneiros, considerando o perfil epidemiológico, a presença das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e as particularidades do contexto das estradas.

Também foram apresentadas estratégias práticas para qualificar a atuação na Atenção Primária à Saúde, com ênfase na detecção precoce, no manejo e na continuidade do cuidado, mesmo diante da mobilidade dessa população.

Mais do que seguir protocolos, cuidar exige reconhecer cada encontro como uma oportunidade de intervenção. Sabendo tudo isso, o que você pode incorporar, a partir de agora, para tornar o cuidado à população caminhoneira mais resolutivas no seu contexto de atuação?

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.336, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 22 set. 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de Atenção Básica, n. 35). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_doenca_cronica_cab35.pdf. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021–2030**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021a. Disponível em:

www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-2022_2030.pdf . Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. **Manual de atenção às pessoas com sobrepeso e obesidade no âmbito da Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021b. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_pessoas_sobrepeso_obesidade.pdf Acesso em: 1 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Diabetes Mellito Tipo 2**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/d/diabetes-melito-tipo-2.pdf/view. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. Instituto Nacional de Câncer (INCA). **Câncer de pele não melanoma**. Rio de Janeiro: INCA, atualizado em 27 maio 2025. Disponível em: www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/pele-nao-melanoma. Acesso em: 15 maio 2026.

CHILDHOOD BRASIL. **O Perfil do Caminhoneiro Brasileiro**. 5. ed. São Paulo: Childhood Brasil; Programa Na Mão Certa, 2025. Disponível em: <https://namaocerta.org.br/pesquisas-e-publicacoes/o-perfil-do-caminhoneiro-brasileiro-2025/>. Acesso em: 20 fev. 2026.

KRISHNAMOORTHY, Y.; SARVESWARAN, G.; SAKTHIVEL, M. Prevalence of hyperension among professional drivers: Evidence from 2000 to 2017: A systematic review and meta-analysis. **Journal of Postgraduated Medicine**, v. 66, n. 2, p. 81-89, 2020. Disponível em: https://journals.lww.com/jopm/fulltext/2020/66020/prevalence_of_hypertension_among_professional.6.aspx. Acesso em: 20 maio 2026.

REIS, L. A. P. *et al.* Obesity, hypertension and diabetes among truck drivers in the middle-west, Brazil. **Bioscience Journal**, Uberlândia, v. 33, n. 2, p. 485-493, 2017. Disponível em: www.researchgate.net/publication/315920374_Obesity_hypertension_and_diabetes_among_truck_drivers_in_the_middle-west_Brazil. Acesso em: 20 maio 2026.

SBD (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES). **Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes – Edição 2025**. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/>. Acesso em: 20 maio 2026.

ZAMPARONI VICTORINO, S. V. *et al.* A look through Latin America truck drivers' health, a systematic review and meta-analysis. **BMC Public Health**, v. 23, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-022-14902-2>. Acesso em: 20 maio 2026.